HELP_Organi_P05 — Groupe A — Audits LOT 1 à 8 — 16 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 5 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

A-001 — Haute — LOT 1 · SSP G1

Emplacement : LOT_1_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › Fichier entier › point 11.B des 11 monographies (exemple D1.7) ; constats L1-M15, L1-M31, L1-M32, L1-M35, L1-L48, L1-L25

Contexte : Le cours V4 donne BOTOX® 100 U par aisselle, 20 à 40 points espacés de 1,5 cm, et présente l'usage palmaire comme une référence ; la V6 ne donne aucune dose. L'audit a lu l'AIPS BOTOX® (n° 52433, état mai 2025) via ODDB : 50 U par aisselle, hyperhidrose axillaire primaire de l'adulte seulement, répétition après 16 semaines au plus tôt. La durée d'effet (6–9 ou 6–12 mois) reste non sourcée.

Question : Quelle est, dans l'AIPS suisse actuelle de BOTOX® (et des autres toxines botuliniques autorisées en Suisse, p. ex. Dysport®, Xeomin®), l'indication exacte dans l'hyperhidrose (axillaire, palmaire), la dose par aisselle, la dilution, la technique d'injection, l'intervalle minimal entre deux séances et la durée d'effet attendue ? L'usage palmaire est-il hors étiquette en Suisse et la LAMal le rembourse-t-elle (Liste des spécialités, limitation) ? Quelle place la recommandation suisse ou l'AWMF 2023 (S1 013-059) donne-t-elle à la toxine botulique par rapport au chlorure d'aluminium et à l'iontophorèse ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-008 — Haute — LOT 1 · SSP G1

Emplacement : LOT_1_Appel_B_V4_Argon_Expert_Complet__export_GoogleDoc.html › Partie 3 › D1.7 › point 11.B › 1re intention curative ; constats L1-M44

Contexte : La V4 cite le « méthimazole » (non commercialisé en Suisse), omet l'agranulocytose et affirme que le propranolol « arrête immédiatement les sueurs » ; l'audit renvoie à l'ETA 2018 et à Néo-Mercazole® selon l'AIPS.

Question : Quelles doses initiales et d'entretien du carbimazole (Néo-Mercazole®) et du propylthiouracile prévoit l'AIPS suisse dans la maladie de Basedow, avec surveillance (hémogramme, transaminases) et consigne d'arrêt en cas de fièvre ou d'angine ? Quel bêtabloquant et quelle dose recommande-t-on ? Existe-t-il une version de la recommandation ETA plus récente que 2018 et qu'a-t-elle changé ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-009 — Haute — LOT 1 · SSP G1

Emplacement : LOT_1_Appel_B_V4_Argon_Expert_Complet__export_GoogleDoc.html › Partie 4 › D1.8 › point 11.B › pharmacologique ; constats L1-M45, L1-L35, L2-M20

Contexte : Le cours cite Benadon® 40 mg/j en pyridoxine « systématique » (Benadon® n'existe qu'en 300 mg en Suisse) et ne donne pas le nombre de comprimés de Rimstar® selon le poids ; l'audit a lu l'AIPS Rimstar® (avril 2026). Même lacune au LOT_2 (D2.4 › point 11.B, co-prescription de pyridoxine).

Question : Quelle est la recommandation de la Ligue pulmonaire suisse / Centre de compétence tuberculose (manuel tuberculose, édition la plus récente) pour le traitement de la tuberculose sensible : schéma, dose de Rimstar® par tranche de poids, durée, dose de pyridoxine et groupes à risque concernés ? Quelle spécialité ou préparation suisse permet la dose prophylactique de pyridoxine ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

A-010 — Haute — LOT 1 · SSP G1

Emplacement : LOT_1_Appel_B_V4_Argon_Expert_Complet__export_GoogleDoc.html › Partie 4 › D1.10 › point 11.B › préparation chirurgicale ; constats L1-M46, L1-L38

Contexte : La V4 propose l'urapidil oral (Ebrantil® n'existe qu'en injectable en Suisse) et la doxazosine 2–16 mg sans source ; l'audit propose Cardura® CR 4 mg et cite la prise de position ESH 2020 (Lenders et al.).

Question : Quel schéma de préparation préopératoire du phéochromocytome recommande la source européenne la plus récente (ESE/ESH, consensus 2020 ou ultérieur) : molécule, dose initiale, titration, durée, cibles tensionnelles, apport hydrosodé, place des bêtabloquants et des inhibiteurs calciques ? Quelles formes de doxazosine et de phénoxybenzamine sont disponibles en Suisse selon l'AIPS ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-002 — Moyenne — LOT 1 · SSP G1

Emplacement : LOT_1_Appel_B_V4_Argon_Part1_D1.1_D1.2__export_GoogleDoc.html › D1.1 › point 11.B › 1re intention (2 occurrences, aussi dans le fichier V4 Expert Complet, D1.1 › 11.B : « SweatStop®, Odaban® ») ; constats L1-M36, L1-M38, L1-L54, L1-L26, L1-L51, L1-L24

Contexte : Le cours cite Perspirex (« Perspirx »), SweatStop®, Odaban®, Excipial® DeoForte comme spécialités ®, présente Axhidrox® comme une recherche 2026 et attribue 82 % de réduction stable au traitement par micro-ondes sans source ; il qualifie l'application sur peau humide de « brûlure chimique sévère ».

Question : Quels topiques de l'hyperhidrose sont autorisés par Swissmedic (statut de médicament ou de cosmétique du chlorure d'aluminium hexahydraté, concentration, préparation magistrale) et quelle est l'AIPS d'Axhidrox® (glycopyrronium 2,2 mg/pression) : indication, schéma, contre-indications, remboursement ? Quel rythme d'application du chlorure d'aluminium recommande l'AWMF 2023 ou une source suisse ? Quelle étude publiée (auteur, année, NCT) chiffre l'efficacité du traitement par micro-ondes (miraDry®) et est-il disponible en Suisse ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-003 — Moyenne — LOT 1 · SSP G1

Emplacement : LOT_1_Appel_B_V4_Argon_Part1_D1.1_D1.2__export_GoogleDoc.html › D1.1 › point 11.B › 3e ligne systémique (aussi fichier V4 Expert Complet, D1.4 › 11.B, « Ditropan® 2,5 mg/j ») ; constats L1-M37

Contexte : Le cours cite Ditropan® 2,5 mg/j per os (non autorisé en Suisse selon l'audit) et Kentera® comme comprimé (c'est un patch) pour l'hyperhidrose ; l'audit propose Oxybutynin Macure® 5 mg hors étiquette.

Question : Quelles spécialités d'oxybutynine orale et d'autres anticholinergiques systémiques (glycopyrronium, méthanthéline) sont autorisées en Suisse, et quelle dose initiale, titration et contre-indications recommande-t-on dans l'hyperhidrose (usage hors étiquette) selon l'AIPS et l'AWMF 2023 ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-004 — Moyenne — LOT 1 · SSP G1

Emplacement : LOT_1_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › SSP G1 › point 2 Épidémiologie ; constats L1-M24, L1-M28, L1-L20, L1-M33, L1-L28, L1-M25

Contexte : L'Appel A donne 1–3 %, 0,6–2,8 %, 10–41 % (soins primaires nord-américains), un pic à 41–55 ans, 12 % des enfants, un âge d'atténuation de 40 ans (45 ans dans la V4) et « 95 % des cas », sans source ; les badges de fréquence des 10 DX citent AAFP, ADA ou « Revue Médicale Suisse » sans URL. La V6 a tout remplacé par « donnée non trouvée ».

Question : Quelles données publiées suisses, à défaut européennes, chiffrent la prévalence de l'hyperhidrose primaire (axillaire, palmaire), des sueurs nocturnes en soins primaires et l'âge de début et d'atténuation spontanée ? Donne pour chaque chiffre la population, l'année, l'auteur et l'URL. Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-005 — Moyenne — LOT 1 · SSP G1

Emplacement : LOT_1_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › D1.2 › point 8 Critères ; constats L1-M23, L1-M40, L1-L49, L1-M41, L1-L50

Contexte : Le cours écrit « âge habituel » pour le diagnostic clinique de ménopause, un seuil d'œstradiol de 20 pg/mL (≈ 73 pmol/L, calcul dérivé), une durée des bouffées vasomotrices de 7,4

ans (cohorte américaine) présentée comme suisse et un âge médian « en Suisse » sans source ; l'audit cite NICE NG23 2024 et ESHRE POI 2024.

Question : Quelle recommandation suisse (SSGO / Société suisse de ménopause, avis d'experts) ou européenne (EMAS, ESHRE 2024) définit le diagnostic clinique de la ménopause (âge, durée d'aménorrhée), le diagnostic d'insuffisance ovarienne prématurée (seuil de FSH, nombre de dosages, intervalle) et l'utilité d'un dosage d'œstradiol (seuil en pmol/L) ? Quels chiffres européens ou suisses donnent l'âge médian de la ménopause et la durée moyenne des symptômes vasomoteurs ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-006 — Moyenne — LOT 1 · SSP G1

Emplacement : LOT_1_Appel_B_V4_Argon_Expert_Complet__export_GoogleDoc.html › Partie 1 › D1.2 › point 11.B › pharmacologique ; constats L1-M39, L1-L52

Contexte : Le cours cite Estramon® (non autorisé en Suisse, l'audit propose Estradot® 50 µg/24 h) et les essais OASIS sans NCT ni statut d'autorisation ; la V4 mentionne le fézolinétant (Veoza®) autorisé par Swissmedic.

Question : Quelles spécialités suisses d'estradiol transdermique et de progestatif (Estradot®, Oestrogel®, Utrogestan®…) recommande l'avis d'experts suisse pour les symptômes vasomoteurs, avec dose initiale et schéma ? Quel est le statut Swissmedic en 2026 de l'élinzanétant (essais OASIS 1–4, NCT) et du fézolinétant (Veoza®) : indication, dose, surveillance hépatique, remboursement ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-011 — Moyenne — LOT 1 · SSP G1

Emplacement : LOT_1_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › D1.9 › point 8 Critères ; constats L1-M22, L1-L37

Contexte : Le cours ne chiffre pas les symptômes B du lymphome et affirme un « standard suisse » de traitement sans source ni NCT ; l'audit cite ESMO 2018 et Lugano 2014.

Question : Quels sont les critères chiffrés des symptômes B (fièvre, sueurs, perte de poids, durée) selon la classification de Lugano et la recommandation ESMO la plus récente du lymphome de Hodgkin, et quel traitement de première ligne recommandent l'ESMO et le groupe suisse SAKK en 2026 ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année,

URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-012 — Haute — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_A_Plan_et_Liste_Fédéral__export_GoogleDoc.html › Bloc 1 › point 10 Arbre décisionnel ; constats L2-M07, L2-M10, L2-M13, L2-L25, L2-L59, L2-M08

Contexte : L'arbre envoie toute masse persistante vers une exérèse d'emblée ; le point 8 omet le ganglion sus-claviculaire et attribue des critères à la SSMIG, à l'OFSP, à la SSI et à la SAKK sans document identifiable. L'audit cite les guidelines britanniques 2016, Fijten 1988 et Hanzalová & Matter, Swiss Med Wkly 2024 (malignité 1,1–8,1 %).

Question : Quelle recommandation suisse ou européenne définit la démarche devant une adénopathie périphérique ou une masse cervicale de l'adulte : seuils de taille, localisations suspectes, délai d'observation, place de l'échographie, de la cytoponction échoguidée et de la biopsie-exérèse, orientation ORL ? Quels chiffres suisses donnent la probabilité de malignité en soins primaires ? Existe-t-il un document SSMIG, SSI ou SAKK portant sur ces critères (titre, année, URL) ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-014 — Haute — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_B_V4_Argon_Partie_2_D2.3_a_D2.5__export_GoogleDoc.html › D2.3 › point 11.B › corticoïdes (4 autres occurrences : D2.5 point 11.B R-CHOP ; D2.9 point 11.B et point 14 ; D2.1 point 14) ; constats L2-M14, L2-L48, L3-M33, L3-M44, L3-L30

Contexte : Le cours écrit « Prednisone (Spiricort®) » dans 5 occurrences au LOT_2 (D2.3, D2.5, D2.9, D2.1) et 2 au LOT_3 (D3.5 › point 5, D3.7 › 11.B, 40 mg/j) ; l'audit a vérifié que Spiricort® contient de la prednisolone (H02AB06).

Question : Quelles spécialités de prednisone et de prednisolone sont autorisées et commercialisées en Suisse en 2026 (nom, dosages, titulaire) et quelle équivalence de dose l'AIPS indique-t-elle entre prednisone, prednisolone, méthylprednisolone et dexaméthasone ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-017 — Haute — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_B_V4_Argon_Partie_2_D2.3_a_D2.5__export_GoogleDoc.html › D2.5 › point 11.D › thérapies cellulaires CAR-T ; constats L2-M21

Contexte : Le cours présente le tisagenlecleucel (Kymriah®) en 2e ligne du lymphome B diffus à grandes cellules ; l'audit a vérifié qu'il n'est autorisé qu'après deux lignes ou plus.

Question : Quelles indications exactes Swissmedic a-t-il autorisées en 2026 pour Yescarta®, Breyanzi® et Kymriah® dans le lymphome B diffus à grandes cellules (ligne, rechute précoce, réfractaire), et lesquelles la LAMal rembourse-t-elle ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-013 — Moyenne — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_A_Plan_et_Liste_Fédéral__export_GoogleDoc.html › Bloc 1 › point 11 › B- Moyens et méthodes ; constats L2-M11, L2-L17

Contexte : Le point 11.B cite l'amoxicilline-acide clavulanique sans spécialité, dose, voie, durée, adaptation rénale ni contre-indication.

Question : Quelle dose adulte et pédiatrique, quelle durée et quelle adaptation rénale l'AIPS d'Augmentin® (et des génériques suisses) prévoit-elle, et quelle recommandation SSI (guidelines.ch) précise l'antibiothérapie d'une adénite ou d'un abcès cutané cervical ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-015 — Moyenne — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_B_V4_Argon_Partie_1_D2.1_a_D2.2__export_GoogleDoc.html › D2.2 › point 11.B › Moyens pharmacologiques › anesthésie locale ; constats L2-M15

Contexte : Le cours écrit lidocaïne avec adrénaline 1:100 000 (Rapidocain® mit Epinephrin contient 5 µg/mL, soit 1:200 000) et une dose maximale de 7 mg/kg non tirée de l'AIPS.

Question : Quelle dose maximale de lidocaïne avec et sans adrénaline donne l'AIPS suisse de Rapidocain® et Rapidocain® mit Epinephrin (mg/kg et mg absolus), et quelles contre-indications (extrémités, bloc digital) mentionne-t-elle ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-016 — Moyenne — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_B_V4_Argon_Partie_2_D2.3_a_D2.5__export_GoogleDoc.html › D2.3 › point 11.B › Moyens pharmacologiques symptomatiques ; constats L2-M19

Contexte : Le cours fixe un seuil « ALAT > 2 fois la norme » pour préférer l'ibuprofène au paracétamol dans la mononucléose, sans source.

Question : Quelles adaptations hépatiques prévoient les AIPS de Dafalgan® (paracétamol) et d'Irfen® (ibuprofène) : dose maximale, seuils de transaminases ou de Child-Pugh, poids < 50 kg ? Une source suisse ou européenne recommande-t-elle un antalgique préférentiel en cas de cytolyse hépatique de la mononucléose ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P05 — 16 questions : A-001, A-008, A-009, A-010, A-002, A-003, A-004, A-005, A-006, A-011, A-012, A-014, A-017, A-013, A-015, A-016